

Coarctation de l'Aorte

Pr RABEARIVONY Nirina
Cardiologue

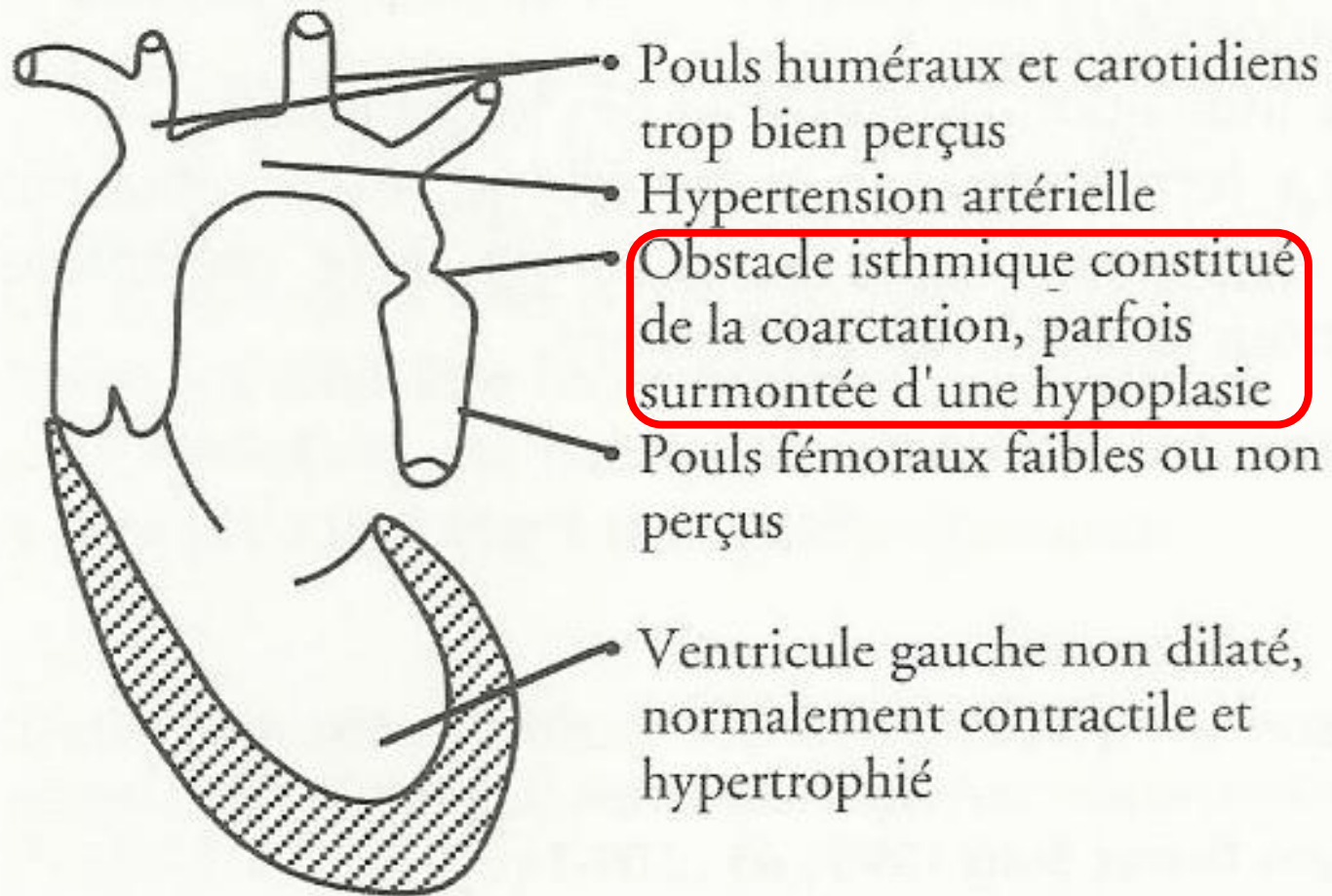
Plan

- Introduction
- Physiopathologie
- Signes
- Diagnostic
- Traitement

Introduction

- **Définition:**
 - **rétrécissement congénital de l'isthme de l'AO**
(entre la naissance de la sous - clavière gauche et la zone d'implantation du CA)
- **Epidémiologie:**
 - **représente 10% des cardiopathies congénitales**
 - **prépondérance masculine (2/1)**

Introduction



Physiopathologie

- **Coarctation → Hypertension d'amont (M Sup)**
Hypotension d'aval (M Inf)
- **Au cours de l'enfance → développement progressif d'une circulation collatérale qui court-circuite l'obstacle isthmique**

Signes

- Circonstances de découverte:
 - **nourrisson:**
 - tableau d' IC
 - souvent associée à: CIV, PCA, RA
 - **grand enfant:**
 - SF d'HTA (céphalées, épistaxis, ...)
 - découverte fortuite d'une HTA

Signes

- Signes cliniques: TDD coarc° isolée du grand enfant
 - **palpation**: +++
 - thrill sus-sternal
 - pouls huméraux et carotidiens trop forts
 - pouls fémoraux trop faibles ou abolis
 - présence de pouls intercostaux
 - **auscultation**:
 - discrète
 - SS doux dans gouttière interscapulaire
 - S continu de circulation collatérale

Signes

- **Signes cliniques:**
 - HTA aux M Sup
- **Radiographie thoracique:**
 - cardiomégalie (constante)
 - image de « double bouton aortique »
 - encoches costales (liées à la circulation collatérale): rares et tardives

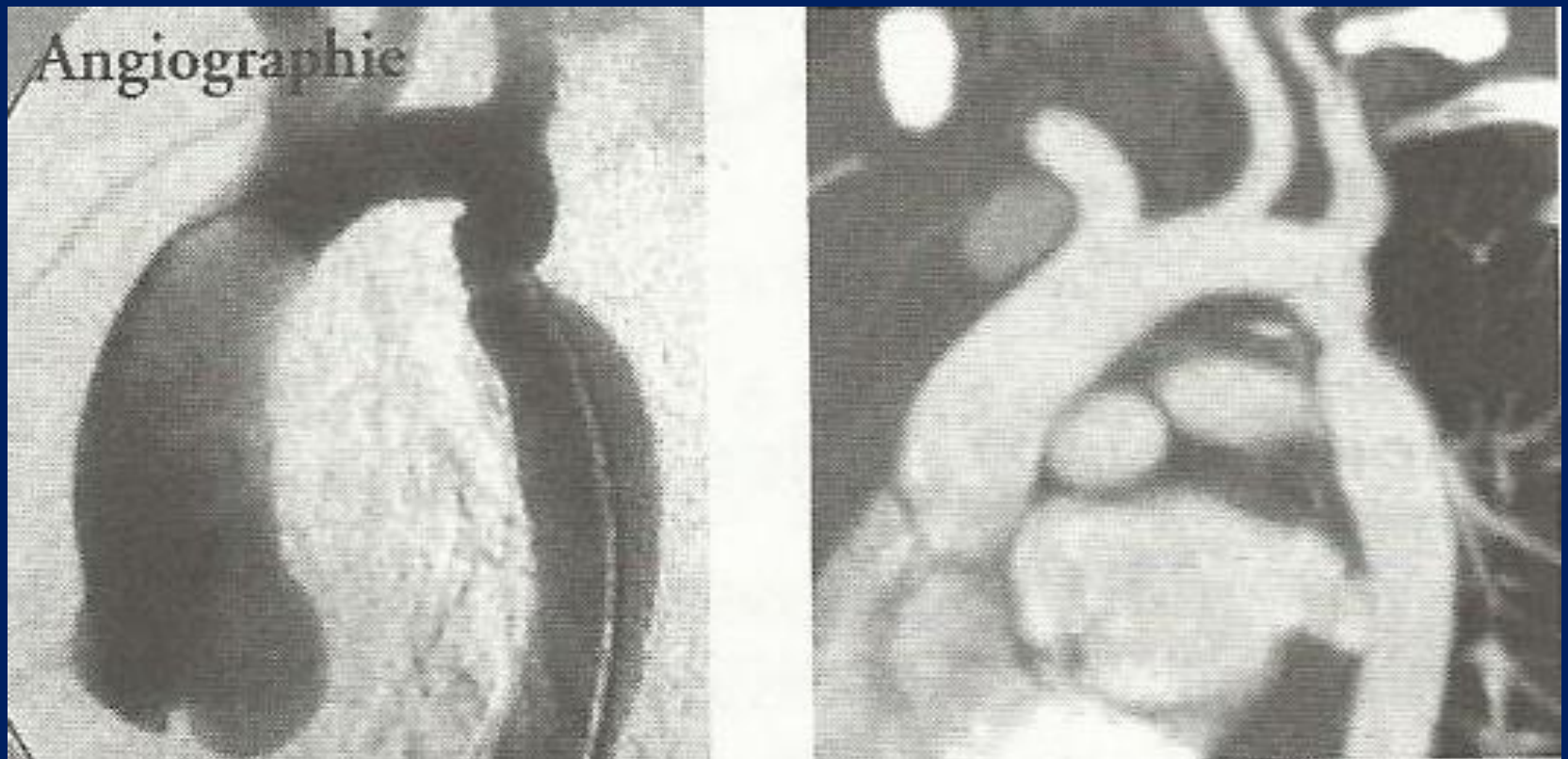
Signes

- **ECG:**
 - normal ou aspect de Bid
 - HVG (tardive) = retentissement de l'HTA
- **Echocardiographie:**
 - apprécie le calibre de l'arche aortique sus-jacente
 - recherche les lésions associées (bicuspidie AO)
 - étudie la fonction VG

Signes

- **Angiographie:**
 - bilan pré-opératoire (apprécier les lésions associées et l'anatomie chirurgicale de l'arche AO)
- **IRM:**
 - plus performante

Signes



Signes

- Evolution spontanée:
 - **Défaillance VG:**
 - coarctation serrée
 - apparait dans la 1^{ère} semaine de vie
 - **HTA:**
 - apparait après 15 jours de vie
 - PAS < 150 mmHg (habituellement)
 - 150 à 200 mmHg → HVG +++
 - > 200 mmHg → crises convulsives
 - après 10 ans d'évolution → HTA irréversible (hyperstimulation SRAA)

Signes

- Evolution spontanée:
 - Endocardite d'Osler
 - anévrisme
- } rares, tardifs

Signes

- Formes cliniques
 - **Formes selon l'âge:**
 - Nourrisson:
 - coarctation serrée + non adaptation du VG
 - tableau d'IC grave, parfois collapsus
 - évolution défavorable (I rénale, décès)
 - diagnostic et traitement d'urgence
 - Grand enfant:
 - asymptomatique pendant plusieurs années
 - Adulte:
 - découverte / complications (HTA, rupture d'anévrisme), décès avant 40 ans

Signes

- Formes cliniques
 - **Formes associés**
 - Syndrome de TURNER (coarctation 20%)
 - autres cardiopathies congénitales
 - bicuspidie AO (50%), CIV, PCA, IM
 - ventricule unique, transposition des gros vaisseaux

Diagnostic

- **Positif**
 - suspecté par l'HTA
 - posé par la palpation (pouls +++)
 - confirmé par l'imagerie

Traitement

- Buts
 - éviter les complications
 - restaurer le flux sanguin normal de l'arche aortique
- Moyens:
 - Médicamenteux
 - Prostaglandine E1 (Prostine*): réouverture du CA
 - furosémide
 - IEC

Traitement

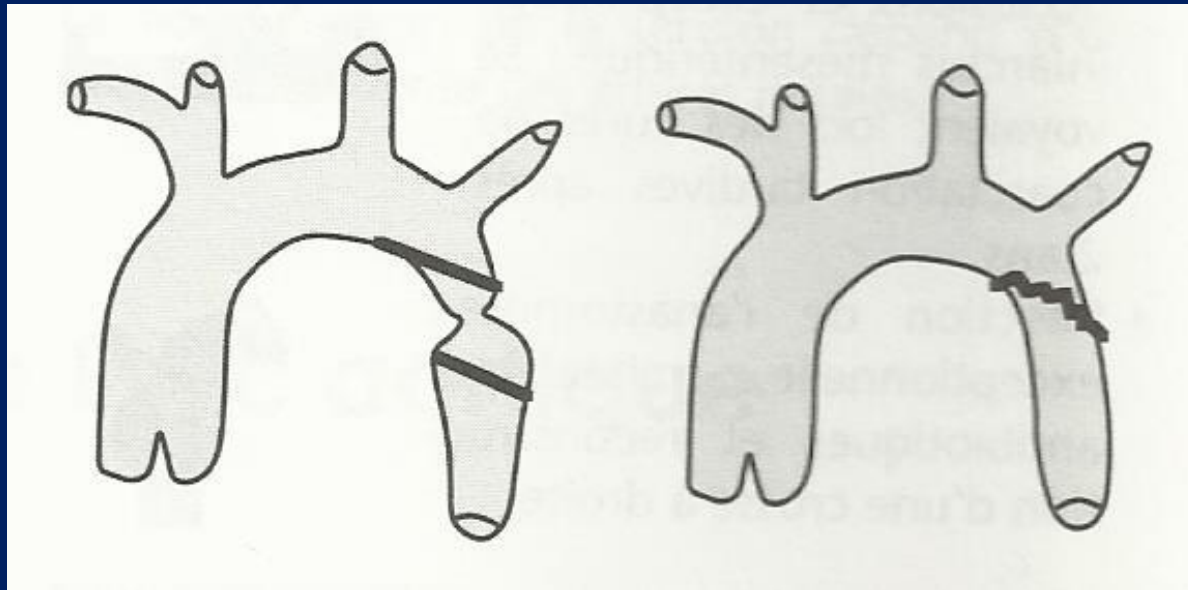
- **Moyens: (suite)**
 - **Cathétérisme interventionnel**
 - **dilatation de la zone rétrécie par un cathéter à ballonnet (voie artérielle fémorale rétrograde)**

Traitement

- Moyens:

- Chirurgie: (suite)

Intervention de CRAFOORD: résection de la zone de coarctation avec suture termino-terminale de l'AO



Traitement

- **Indications:**
 - **Dépistage systématique d'une coarctation chez un N-né sans pouls fémoraux:**
surveillance echo tous les 2 jours jusqu'à 15^{ème} jour de vie
chirurgie après 1 mois
 - **défaillance VG chez le N-né: Tt médical, puis chir après récupération**

Traitement

- Indications:
 - défaillance VG chez le nourrisson ou enfant:
→ chir d'emblée
 - HTA avec PAS > 150 mmHg
→ chir vers 3 mois

Conclusion

- Coarctation = cause d'**HTA secondaire de l'enfant**
- Diagnostic repose sur la clinique
(**HTA + absence de pouls fémoraux**)
- Traitement = chirurgical